PROFESIONAL

EJE 3 · NUEVOS DESAFÍOS DE LA SALUD Y EL CUIDADO

HOSPITAL DE CLÍNICAS
«JOSÉ DE SAN MARTÍN»
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Nuevas tecnologías en cirugía oncológica: impacto en la valoración de enfermería y evolución del paciente

Rearte Ortiz S. Y.[1] · **Equipo de Enfermería en Cirugía Oncológica**[1]

[1] División de Cirugía Oncológica de Cabeza y Cuello · Hospital de Clínicas «José de San Martín» · Universidad de Buenos Aires

1 INTRODUCCIÓN

Históricamente, la cirugía oncológica fue sinónimo de **grandes resecciones**: incisiones amplias, dolor intenso y recuperaciones lentas.

La incorporación de la **ablación por microondas o radiofrecuencia (MWA)** y de la **fluorescencia con verde de indocianina (ICG)** permite abordajes mínimamente invasivos y conservadores en pacientes oncológicos de cabeza y cuello (Bedoya-Ismodes et al., 2024; Pina et al., 2026).

Este cambio de paradigma exige un **nuevo enfoque en la valoración y los cuidados de enfermería** del postoperatorio inmediato (Parks, 2022).

2 OBJETIVOS

Objetivo general: describir los cambios en la valoración clínica y los cuidados de enfermería en el postoperatorio inmediato de pacientes oncológicos intervenidos con nuevas técnicas quirúrgicas.

Específicos:

- Describir las técnicas aplicadas.
- Identificar los cambios en la valoración y los cuidados.
- Relacionarlos con una recuperación más segura y mejor evolución.

3 METODOLOGÍA

Diseño: investigación descriptiva, cualitativa y retrospectiva.

Ámbito y período: Servicio de Cirugía Oncológica de Cabeza y Cuello, Hospital de Clínicas «José de San Martín» (UBA), de octubre de 2025 a abril de 2026.

Población: 46 pacientes oncológicos intervenidos con estas técnicas quirúrgicas.

Procedimientos: MWA, aguja guiada por ecografía que aplica calor sobre el tumor para destruirlo; ICG, colorante visualizado con cámara infrarroja para identificar tejidos, ganglios centinela e irrigación.

Análisis: descripción cualitativa de la valoración y los cuidados de enfermería en el postoperatorio inmediato, en comparación con la cirugía tradicional.

Aspectos éticos: las imágenes se presentan sin datos que permitan identificar a los pacientes.

4 RESULTADOS

A · ABLACIÓN POR MICROONDAS (MWA)

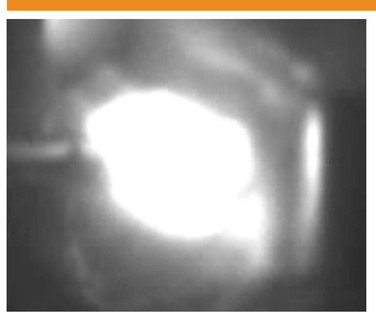


A1. PET-CT preoperatorio (SUV máx. 1,6).



A2. Aguja de ablación aplicada sobre la lesión.

B · FLUORESCENCIA CON ICG



B1. Imagen infrarroja con captación de ICG.



B2. Fluorescencia ICG superpuesta al campo quirúrgico.

Figura 1. Ablación por microondas (MWA) y fluorescencia con verde de indocianina (ICG). Fuente: elaboración propia, Servicio de Cirugía Oncológica de Cabeza y Cuello. Imágenes sin datos identificatorios.

46
pacientes oncológicos intervenidos con MWA o ICG (oct. 2025 – abr. 2026)

10 %
hematomas en cirugía abierta; riesgo casi nulo con ablación (MWA)

Con MWA e ICG se observó un abordaje por punción o mínimamente invasivo, **dolor leve, deambulación precoz y menor débito de drenajes**.

La ablación **preserva el nervio recurrente** y evita la cicatriz cervical visible; la fluorescencia permite extraer solo el tejido necesario.

La valoración de enfermería pasó de un control estricto y constante a uno **dinámico y específico** según la técnica.

Tabla 1. Cirugía tradicional vs. nuevas tecnologías (MWA / ICG). Fuente: elaboración propia.

Aspecto	Cirugía tradicional	Nuevas tecnologías (MWA / ICG)
Abordaje	Grandes incisiones / cirugía abierta	**Punción o abordaje mínimamente invasivo**
Complicaciones	Hipocalcemia, hematomas (10 %), riesgo de disnea	**Mínimas; evolución más eficaz y rápida**
Dolor	Moderado a severo	**Leve**
Movilidad	Reposo prolongado	**Deambulación precoz**
Enfermería	Control estricto y constante	**Control dinámico y específico**

5 CONCLUSIONES

MENSAJE CLAVE

Menos invasión quirúrgica, recuperación más rápida y una enfermería que evoluciona a la par: valoración más dinámica y específica.

Las nuevas tecnologías favorecen una recuperación más rápida, con menor agresión quirúrgica y reincorporación más temprana del paciente a su vida cotidiana.

La enfermería evoluciona a la par, adaptando la valoración y los cuidados a las nuevas necesidades del paciente.

Limitaciones: estudio descriptivo y retrospectivo de un solo servicio (n = 46).

6 APORTE A ENFERMERÍA

Controles específicos según la técnica:

- **Valoración general (ABC):** conciencia, signos vitales y dolor.
- **Herida y piel:** sangrado, hematoma, infección o dehiscencia; en MWA, parche necrótico o lesión térmica.
- **Vía aérea y voz:** permeabilidad, disnea y disfonía (nervio recurrente).
- **Drenajes Jackson-Pratt:** permeabilidad, débito y características.
- **Colgajos y perfusión:** flogosis o placa necrótica; alergia al contraste con ICG.

Exige un aprendizaje técnico más profundo para saber qué vigilar en cada procedimiento.

7 REFERENCIAS

Bedoya-Ismodes, E., Gonzales-Laguado, E., Portugal, K. y Juarez-Herrera, N. (2024). Ablación por radiofrecuencia de nódulos tiroideos; a propósito de un caso exitoso en un hospital público en Perú. *Revista de la Facultad de Medicina Humana, 24*(2), 180–184. https://doi.org/10.25176/RFMH.v24i2.6438

Hospital de Clínicas José de San Martín. (s. f.). *Manual de procedimientos de enfermería: Protocolo de manejo de drenajes Jackson-Pratt y vigilancia de colgajos*. Universidad de Buenos Aires.

Parks, L. (2022). Benefits of minimally invasive surgery for patients with cancer: Nursing implications. *Clinical Journal of Oncology Nursing, 26*(4), 353–357. https://doi.org/10.1188/22.CJON.353-357

Pina, L. N., et al. (2026). Ablación tiroidea por radiofrecuencia y microondas: análisis de eficacia y seguridad en una serie de casos inicial del Hospital de Clínicas José de San Martín.

Hospital de Clínicas «José de San Martín» · UBA
Contacto: rearteortizsilviayasmin@gmail.com